

Información Paciente

Nombre : Ireneo Fernando Herrera Melipil

Edad : 61a 9m 16d

Dirección : Millaray S/N Dpto. 11

Rut : 9.641.567-2

Fecha Nacto: 31/07/1961

Comuna : Viña Del Mar

N° Archivo : 0127920

Sexo : Masculino

Teléfono : 9 9752 2985

N° Epicrisis

351228

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 22/04/2023 23:20

Días Estadía : 24

Unidad de Egreso : Medicina Cuidados Básicos 5° Piso

Fecha Egreso : 16/05/2023 23:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Insuficiencia Renal Aguda

Comorbilidades

Insuficiencia Renal Crónica;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Resumen de Traslado

FI HSR: 23-04-23

FI UTIM: 24-04-23

FI SBM: 27-04-23

FI UTIM: 03-05-23

FI SBM: 10-05-23

Fecha egreso: 16-05-23

ANTECEDENTES:

- Mórbitos: Sd Intestino Corto por isquemia mesentérica, NPTC por CVC reservorio (retirado en Dic 2022 por sobreinfección), desnutrición C-P, trombosis múltiple del territorio esplácnico, DM2 NIR, DLP, TUS PBC, ERC IIIb-IV (HD 2 veces en última hospitalización), enfermedad celíaca.

- Quirúrgicos: Resección intestinal (mayo 2022, queda con 20 cm yeyuno y 5 cm ileon), Instalación y retiro de CVC reservorio (2022, cultivo arrastre (+) C Glabrata)

- Fármacos: SRH 60 mEq al día, pancreatina 25.000 UI 3 v/día pre-comida, omeprazol 20 mg c/12, loperamida 2mg pre-comidas, bicarbonato 1 g al día. Mala adherencia al tratamiento.

- Alergias: No refiere

- Hábitos: TBQ (-), OH (FUC 05/2022 (7 L al día cerveza), Drogas (FUC 05/2022 pasta base, cocaína)

- Hospitalizaciones recientes (2022):

17/11-29/12: Bacteriemia por SAMR + Candidemia por C Glabrata (ITS CVC).

06/10-17/10: Disfunción de reservorio - Desnutrición C-P

11/05-14/07: Isquemia Mesentérica

- Social: Situación de calle

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes descritos acude por cuadro de anorexia y vómitos, asociado a dolor abdominal periumbilical tipo cólico. Refiere además baja de peso de 25 kg desde mayo de 2022. Niega diarrea, melena, fiebre, síntomas urinarios, síntomas respiratorios.

Al ingreso a SU se describe vigil, desorientado, con hemodinamia estable, tendiente a la hipotensión, afebril, sin requerimientos

Fecha Epicrisis : 16/05/2023 23:04

Fecha Última Actualización: 16-05-2023 23:04:45

Página 2 de 3

de O2.

Al examen físico se describe deshidratado, enflaquecido, abdomen sensible a la palpación. Del laboratorio destaca Crea 9.59, BUN 89, Na 133, acidosis metabólica, hiperfosfemia 6.8. OC no inflamatoria (UC pendiente). TAC TAP sin hallazgos sugerentes de infección.

Se hospitaliza en UTIM para continuar manejo y definir conducta.

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS UTIM-SBM-UTIM

- HDN: Normotenso, impresiona con VEC disminuido en contexto de pérdidas por lo que se volemiza con cristaloides en múltiples ocasiones. Actualmente solo con aporte de agua via oral. Sin conflicto actual.

- Nefro/MI: Antecedente de ERC IIIb, con última hospitalización en Nov-Dic 2022 en la que requirió HD en 2 ocasiones, crea 1.9 al alta, sin control posterior. Ingresa cursando AKI KDIGO III sobre ERC (crea 9.6, BUN 90) que se interpreta como prerrenal en contexto de pérdidas GI. Pielo TAC 22/04 con riñones de tamaño normal, microlitiasis sin HUN. Evaluado por Nefrología, se indica volemización y seguimiento con diuresis, logrando escasa mejoría. Desde 01/05 presenta nuevo deterioro de función renal, con estudio etiológico que sugiere origen renal (NTA). Recibe volemización con escasa respuesta pero manteniendo parámetros estables (crea peri 8, BUN 80) sin grandes variaciones, sin sintomatología asociada. Se traslada nuevamente a UTIM el 03/05 por compromiso de conciencia, emperioamiento funcion renal y aumento de parámetros inflamatorios donde evoluciona favorablemente. Se traslada a sala básica el 10/05. En conjunto con equipo de nefrología y jefatura del servicio, y dado mal pronóstico de paciente y ausencia red de apoyo efectiva, no sería candidato a HD de agudos ni crónico y se limita complejidad hasta sala básica.

- Hematológico: Anemia N-N con cinética de hierro no objetiva en contexto de inflamación. Se interpreta como multifactorial (AEC, ERC). Se transfunden en 2 oportunidades en hospitalización. Actualmente con ultima hemoglobina 7,7. Por ahora observar

- Infeccioso: Al ingresarse encontrba afebril, PPII bajos, TAC sin hallazgos sugerentes de infección, SO no inflamatorio. Se rescata UC (+) E faecium Van B por lo que recibió linezolid por 2 días. Luego desde 03/05 con PCR al alza, sin fiebre o focalidad clínica. Se pancultiva y se inicia meropenem de forma empírica. Se rescata en urocultivo nuevamente ERV por lo que se suspende meropenem (completó 4 días) y se inicia linezolid completando 7 días (12/05). Buena respuesta objetivada por disminució n de parametros inflamatorios y clinica. Sin conflicto actualmente.

- Nutrición: Paciente con Sd de Intestino Corto. Evaluado por ANI, indican que reinicio de NPTC quedaría sujeto a red de apoyo (la que se desestima de momento). Se hizo carga con tiamina. Se mantiene con acido folico. Actualmente con alimentación via oral.

- Social: Paciente en situación de calle, evaluado por AS quien conversa con hermana (Sra. Ma. Angelica fono: +569 54571214, Sra. Marisol Valdivia fono: +569 75229857) que se podría hacer cargo de cuidados al alta en Viña del Mar, donde paciente además tiene registro de dirección en FONASA. Al comunicarse con familiares nuevamente el 05/05 estos refieren que ya no se pueden hacer cargo de paciente dado que no disponen de habitación donde recibirlo. Dado a pronostico de paciente y escasa red de apoyo se decide presentar UGCC para continuar manejo conservador en hospital de menor complejidad.

MANEJO: HASTA sala

DIAGNÓSTICOS DE TRASLADO

1.AKI KDIGO 3 sobre ERC III

a.Acidosis metabólica

b.Hipokalemia leve

c.Hiponatremia leve

2.UC (+) Enterococcus faecium Van B (05/05) Con tratamiento ATB con linezolid 7/7

3.Anemia N-N moderada multifactorial

Antecedentes

Diagnóstico de Egreso

Enfermedad Renal Crónica -

Condición de Egreso Otro

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente hemodinámicamente estable, afebril y sin requerimientos de oxígeno. Buena tolerancia oral. Diuresis +, deposiciones +

Plan Post Alta

Fecha Epicrisis : 16/05/2023 23:04

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 16-05-2023 23:04:45

Página 3 de 3

Generales

- Reposo relativo
- Régimen bajo en Na, P, K, 1200 kcal totales, blando sin residuos, celíaco

Medicamentos

Bicarbonato de Na 2 g c/6 h VO
Carbonato de Ca 1 g c/8 h (con comidas) VO
Ac Fólico 5 mg/día VO
Loperamida 2 mg c/8 h VO
Haloperidol 2,5 mg SOS
Risperidona 0,5 mg c/12 h VO

Manejo HASTA SALA

Se solicita traslado a hospital San Jose de Maipo.

Indicaciones

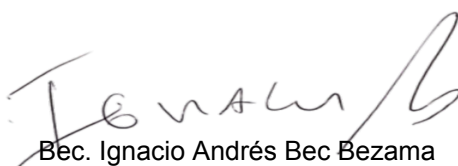
Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

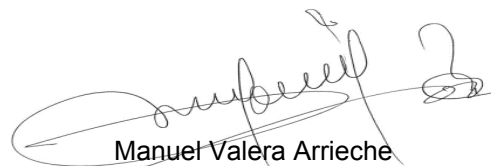
Controles

INTERNO



Bec. Ignacio Andrés Bec Bezama

Becado/Residente



Manuel Valera Arrieche

Médico Tratante (Staff)